

## 1. DATOS GENERALES:

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE: ANA CENOBIA ARIZA DE LA HOZ                 | H.C: 39085431                       |
| EDAD: 70 Años                                       | FECHA DE NACIMIENTO: 12/02/1950     |
| ESCOLARIDAD: Básica primaria                        | FECHA DE EVALUACIÓN: 20, 22/10/2025 |
| DIRECCION: Manzana 4 casa 53 Urbanización Santorini | CORREO: Anapaolagomez1990@gmail.com |
| EPS: Particular                                     | EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega       |
| ACOMPANANTE: NA                                     | CELULAR: 3135251159                 |

### MOTIVO DE CONSULTA

Hija refiere, lo del pasado lo retiene mucho, olvida lo del presente, repite las cosas mucho, se coloca de mal humor.

### ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde hace aproximadamente un año caracterizado por olvidos de hechos recientes, repite lo que dice porque lo olvido, de forma reiterada, en ocasiones se levanta gritando por el hijo de la hija menor, relacionada con una pérdida de un hijo hace 10 años.

Agrega episodios de mal humor, dice que se quiere ir, no viaja sola, se pasó del lugar donde debió quedarse, sale de un lugar para otro y olvida lo que iba hacer en el camino, en ocasiones no sabe dónde deja las cosas, debe detenerse a pensar para poder recordar, puede discutir porque dice que le esconden las cosas o que le están robando, le cuesta aprender nueva información, puede buscar las cosas como llaves teniéndolas en su cuerpo y no las encuentra.

Episodios de mal humor de forma reiterativa, quejas subjetivas por muerte de dos hijos, un nieto de forma violenta.

### ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: HTA.

Quirúrgicos: Si.

Medicación: Losartam, Metoprolol.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

### ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

### HISTORIA EDUCATIVA

Paciente quien cursó hasta básica primaria, refiere que no hizo más estudios, agrega que en esos tiempo el bachillerato lo hacían los ricos que podían mandar los hijos para estudiar. Agrega facilidad de aprendizaje, adecuada lectura, escritura.



### **HISTORIA LABORAL**

Hace aproximadamente 20 años, estuvo dedicada al hogar, antes de esto laboro en plato magdalena clasificando tabacos por más de 5 años.

### **HISTORIA FAMILIAR**

Paciente convive con hija menor, dos hijos, yerno, tuvo 6 hijos, dos hijos fallecieron de forma violenta, un año después fallece de un infarto el esposo, hermano falleció un año después, madre falleció de enfermedad de Alzheimer.

Mantiene relación funcional, lazos de cercanía y funcionales de relaciones sociales, cohesión en las relaciones familiares, comparte con mayoría de personas sus costumbres, cultura material, adecuado nivel de conciencia, integración interna y relaciones con la comunidad.

### **HISTORIA SOCIAL**

La paciente mantiene adecuadas relaciones interpersonales. Se observa que cuenta con un grupo de amigos con quienes comparte diversas actividades como el grupo de la iglesia y las vecinas. Participa activamente en espacios sociales, muestra disposición para interactuar y mantener conversaciones, y se relaciona de manera respetuosa y empática con las personas de su entorno. Refleja habilidades sociales acordes a su edad, evidenciando buena adaptación y facilidad para establecer y mantener vínculos afectivos significativos.

### **HISTORIA SOCIOAFECTIVA**

Pacientes con episodios de mal humor de forma reiterativa, antes era muy prudente, ahora pierde la tranquilidad con facilidad, llora de forma reiterativa cuando recuerda a los hijos quienes fallecieron de forma violenta, recuerda al esposo, madre, padre y hermano, se observa bradilalia, bradipsiquia, posible depresión acompañada de estrés postraumático.

### **CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA**

Paciente con adecuada presentación personal, se muestra alerta, motivada, entusiasta, inadecuada higiene postural, orientada auto y desorientada alopsiquicamente, lenguaje y pensamiento fluido, bradilalia, bradipsiquia, problemas en memoria episódica, no fallas comprensivas, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparente normal, no restricciones en la locomoción, se muestra colaboradora.

### **PRUEBAS APLICADAS**

Protocolo neuropsicológico para valoración de las funciones mentales superiores: Se realizó evaluación de adultos aplicando El Montreal Cognitive Assessment (MoCA) es una breve prueba de cribado para evaluar la función cognitiva y explora 6 dominios: memoria (5 puntos), capacidad visuoespacial (4 puntos), función ejecutiva (4 puntos), atención/concentración/memoria de trabajo (5 puntos), lenguaje (5 puntos) y orientación (6 puntos).

Neuropsi 3: Orientación, (auto y alopsíquica), atención (dígitos en progresión, detección visual, series sucesivas), memoria, ( dígitos en regresión, cubos en regresión, curva de memoria, pares asociados, memoria lógica, figura de rey, caras, memoria verbal claves, memoria verbal reconocimiento), funciones ejecutivas (fluidez verbal semántica, fonológica,



funciones motoras, stroop). - Praxias: (Figura compleja de rey copia - Praxias ideacionales e ideomotoras). Funciones ejecutivas: Criterios DSM V y CIE 10 - Mini mental - Escala de depresión Yesavage - Escala de AVD e Instrumentales) - Escala Global de deterior. (EDG).

| MONTREAL COGNITIVE ASSESMENT |                  |                                                  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| TIPO DE PRUEBA               | PUNTUACION       | INDICADOR                                        |
| <b>TAREAS</b>                |                  |                                                  |
| Visoespacial/Ejecutiva       | <b>0</b>         | <b>5</b>                                         |
| Identificación               | <b>1</b>         | <b>3</b>                                         |
| Memoria                      | <b>No puntos</b> |                                                  |
| Atención                     | <b>1</b>         | <b>6</b>                                         |
| Lenguaje                     | <b>0</b>         | <b>3</b>                                         |
| Abstracción                  | <b>0</b>         | <b>2</b>                                         |
| Recuerdo diferido            | <b>0</b>         | <b>5</b>                                         |
| Orientación                  | <b>1</b>         | <b>6</b>                                         |
| Total                        | <b>3</b>         | <b>Anormal 3/30 DETERIORO COGNITIVO MODERADO</b> |
|                              |                  |                                                  |

*Las puntuaciones obtenidas reflejan un patrón anormal de 3 de 30/ con promedio de 26 lo cual es un punto débil normativo.*





### PERFIL NEUROPSI ATENCIÓN Y MEMORIA

**Nombre y apellido** ANA CENOBIA ARIZA DE LA HOZ  
**Fecha evaluación** 20/10/2025  
**Fecha nacimiento** 26/10/1995  
**Edad** 70 años  
**Grado escolar** Básica primaria  
**Baremos** Baremos Edad: 65 a 85 años Escolaridad: 4 a 9 años

3ª edición

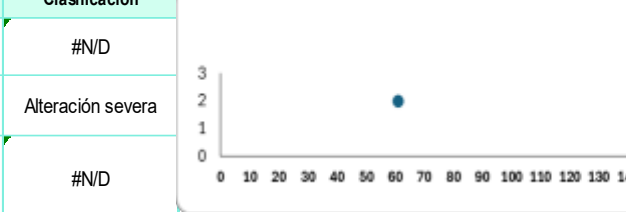
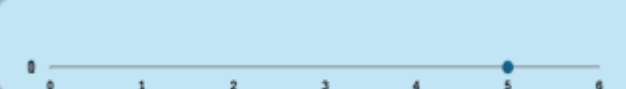
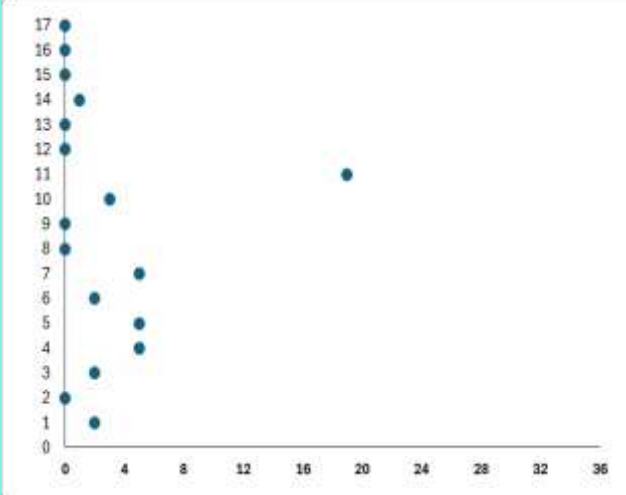
# Neuropsi

## Atención y Memoria

### SubEscala y Puntuación Máxima

### GRAFICO ASOCIADO A PUNTAJE NORMALIZADA

| ORIENTACIÓN                                        | Puntuacion Natural | Puntuacion Reclasificada |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Tiempo (4)                                         | 3                  | 1                        |
| Espacio                                            | 1                  |                          |
| Persona                                            | 1                  |                          |
| ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN                           | Puntuacion Natural | Puntuacion Reclasificada |
| Retención de dígitos en progresión                 | 4                  | 1                        |
| Cubos en progresión                                | 0                  |                          |
| Detección visual aciertos                          | 2                  |                          |
| Detección dígitos total                            | 2                  |                          |
| Series sucesivas                                   | 0                  |                          |
| MEMORIA                                            | Puntuacion Natural | Puntuacion Reclasificada |
| Trabajo. Retención de dígitos en regresión         | 2                  | 1                        |
| Trabajo. Cubos en regresión                        | 0                  |                          |
| Codificación. Curva de memoria volumen promedio    | 2                  |                          |
| Codificación. Pares asociados volumen promedio     | 5                  |                          |
| Codificación. Memoria lógica promedio historias    | 5                  |                          |
| Codificación. Memoria lógica promedio temas        | 2                  |                          |
| Codificación. Figura Semicompleja / Rey-Osterreith | 5                  |                          |
| Codificación. Caras                                | 0                  |                          |
| Evocación. Memoria verbal espontánea               | 0                  |                          |
| Evocación. Memoria verbal por claves total         | 3                  |                          |
| Evocación. Memoria verbal reconocimiento total     | 19                 | 1                        |
| Evocación. Pares asociados total                   | 0                  | 1                        |
| Evocación. Memoria lógica promedio historias       | 0                  |                          |
| Evocación. Memoria lógica promedio temas           | 1                  |                          |
| Evocación. Figura semicompleja / Rey-Osterreith    | 0                  |                          |
| Evocación. Nombres                                 | 0                  |                          |
| Evocación. Reconocimiento total de caras           | 0                  |                          |
| FUNCIONES EJECUTIVAS                               | Puntuacion Natural |                          |
| Formación de categorías                            | 5                  |                          |
| Fluidez verbal semántica (reclasificada)           | 15                 | 2                        |
| Fluidez verbal fonológica (reclasificada)          | 4                  | 1                        |
| Fluidez no verbal total (reclasificada)            | 10                 | 2                        |
| Funciones motoras total                            | 9                  |                          |
| Stroop puntuación interferencia (reclasificada)    | 16                 | 3                        |
| Stroop aciertos interferencia (reclasificada)      | 1                  | 1                        |
| PUNTUACIONES TOTALES                               | Puntuación Natural | Puntuación Normalizada   |
| Total atención y funciones ejecutivas              | 36                 | #N/D                     |
| Total memoria                                      | 44                 | 61                       |
| Total atención y memoria                           | 80                 | #N/D                     |



| TIPO DE PRUEBA                   |            | PUNTUACION    | INDICADOR                |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| PRAXIAS<br>(IDEACIONALES)        | CORPORALES | 10/20         | [ANORMAL]                |
|                                  | CORPORALES | 24/40         | [ANORMAL]                |
| PRAXIAS<br>(IDEOMOTORAS)         |            |               |                          |
| ESCALAS                          |            | PUNTUACION    | INDICADOR                |
| INDICE DE BARTHEL                |            | 50/50         | SIN DIFICULTAD           |
| INDICE DE KATZ                   |            | 2/6           | INCAPACIDAD LEVE         |
| YESAVAGE                         |            | 2/15          | SIN DEPRESIÓN            |
| LAWTON Y BRODY                   |            | 14/30         | DEPENDENCIA MODERADA     |
| ESCALA DE MEMORIA                |            | QP: 36 QF: NA | DIFICULTAD SEVERA        |
| ESCALA GLOBAL DE DETERIORO - EDG |            | 4/7           | DETERIORO COGNITIVO LEVE |

### IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

G301 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER COMIENZO TARDIO.

### CONCLUSION

Según análisis clínico, criterios diagnóstico CIE y evaluación de pruebas cognitivas se determina la existencia de perfil de enfermedad de Alzheimer caracterizado por; 1) Desorientación autopsíquica y alopsíquica de gravedad severa, la paciente no logra recordar el mes en que nos encontramos, el año, la edad, 2) alteración en la memoria de fijación de gravedad severa, la paciente no logra codificar información aun con apoyo de claves, 3) se observó alteración en la memoria inmediata de gravedad severa, 4) alteración en la memoria episódica prospectiva de gravedad severa, lo que le impide grabar información reciente, 5) alteraciones en la atención sostenida auditiva de gravedad moderada, 6) alteración en la memoria de trabajo de gravedad severa, 7) dispraxias viso construccionales, dispraxia ideacionales e ideomotoras, 8) alteración en la fluidez semántica y fonológica, 9) alteración abstracción, 10) alteración en calculo de gravedad severa, 11) alteración en la memoria a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal y visual, 12) la comprensión esta afectada para el seguimiento de instrucciones, acompaña de anosognosia, ( poca conciencia enfermedad), 13) alteración en la capacidad de aprendizaje, 14) se observó marcada afectación de las funciones ejecutivas, ( se ha reducido la capacidad de pensamiento complejo, de flexibilidad, de meta memoria, baja capacidad de planificación, secuenciación, organización), con inicio de afectación de las actividades instrumentales con conservación de autocuidado.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por que existen dos o más procesos cognoscitivos comprometidos alterado que incluyen, 1) la memoria, 2) la alteración en aprendizaje, + 3) otro proceso cognoscitivo: sin que exista alteración en las actividades de la vida diaria instrumentales o de autocuidado y alimentación como: la capacidad para usar el teléfono, ir de compra, capacidad para manejar la medicación, conservación del auto cuidado y alimentación: vestido, desvestido, deposición, micción, locomoción.



Se recomienda a neurología enviar exámenes de tomografía por emisión de positrones, prueba de p-tau y el péptido beta amiloide.

**DIFICULTADES:**

Aprendizaje

Memoria visual a corto y largo plazo.

Discriminación de evocación de palabras asociadas.

Memoria semántica con incremento asociativo.

Memoria de fijación

Control mental

Atención alternante

Memoria de trabajo

Seguimiento de instrucciones.

Orientación auto psíquica.

Orientación alopsíquica.

Memoria a largo plazo explícita tipo semántica.

FAS fonológico y semántico

Funciones ejecutivas

Memoria episódica

Memoria de fijación

Lenguaje: Denominación, repetición, comprensión, lectura

Praxias

Memoria a corto y largo plazo auditiva verbal.

Atención sostenida y focalizada.

**HABILIDADES CONSERVADAS.**

Sintaxis.

Gnosias

Memoria sensorial ecoica.

Memoria a largo plazo tipo implícita procedimental, habituación.

Autonomía relacionada con las actividades personales e instrumentales.

AVD y alimentación.

Velocidad de procesamiento.

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Consulta por neuropsicología en tres meses.

Se recomienda ajustar medicación, memantina, rivastigmina o según considere el especialista de neurología según la nosología.

Evaluación por neuropsicología en 12 meses para determinar curso de la enfermedad.

Se recomienda trabajar rehabilitación cognitiva 2 veces por semanas por tiempo de dos meses para fortalecer los procesos de memoria inmediata, episódica, de trabajo, memoria a corto y largo plazo, aprendizaje, praxias, atención, calculo, fluidez semántica aspectos afectivos y comportamentales.



## **Generalidades:**

### **1. Estimulación cognitiva**

Realizar actividades diarias que estimulen la memoria y la atención, como:

Recordar fechas, nombres o eventos familiares con apoyo visual (fotos, calendarios, carteles).

Juegos sencillos de asociación o rompecabezas adaptados a su nivel.

Lectura o narración de historias breves para mantener la comprensión y el lenguaje.

Mantener una rutina estructurada, ya que la repetición y la previsibilidad reducen la confusión y la ansiedad.

### **2. Entorno físico y seguridad**

Asegurar un ambiente ordenado, iluminado y tranquilo, evitando ruidos fuertes o desorganización visual.

Colocar señalizaciones o etiquetas (por ejemplo, “baño”, “cocina”) para facilitar la orientación espacial.

Retirar objetos peligrosos (cuchillos, medicamentos, cables sueltos).

Supervisar las salidas del hogar para evitar el deambular sin rumbo (deambulación errante).

### **3. Aspectos emocionales y conductuales**

Mostrar paciencia, empatía y tono de voz calmado al interactuar.

Evitar discusiones o corregir de forma brusca; en su lugar, redirigir la conversación de manera amable.

Validar sus emociones: si expresa miedo, tristeza o enojo, responder con comprensión antes que con lógica.

Fomentar actividades placenteras (música, paseos cortos, arte, jardinería) para favorecer el bienestar emocional.



#### **4. Cuidador y familia**

Es fundamental que el cuidador principal cuente con apoyo emocional y descansos regulares, para evitar el agotamiento físico y mental.

Participar en grupos de apoyo para familiares de pacientes con demencia, donde puedan compartir experiencias y estrategias.

Mantener comunicación constante con el equipo médico y psicológico, reportando cambios en conducta, sueño, apetito o memoria.

#### **5. Recomendaciones clínicas generales**

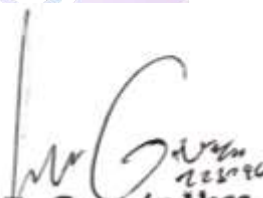
Continuar con seguimiento médico y neuropsicológico periódico cada 3 meses.

Favorecer una alimentación balanceada, hidratación adecuada y horarios regulares de sueño.

En caso de agitación, confusión intensa o riesgo de autolesión, buscar atención médica inmediata.



**PRASCA**  
CENTER



Jainer E. Guzmán Vega  
Psicólogo - M.G Neuropsicología  
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

**Nombre del Profesional: Jainer Guzmán Vega**

**Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad San Buenaventura de Medellín**

**No. Tarjeta Profesional: 123096**

